

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala Administrada por Clínico para el TEPT (CAPS-5)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala Administrada por Clínico para el TEPT
Sigla	CAPS-5
Autores	Weathers, F.W. et al.
Año	2013
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Trauma y estrés postraumático
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Entrevista estructurada clínica
Disponibilidad en español	Sí (Validada por el Consorcio Latinoamericano y Español)
Acceso/licencia	Estado jurídico no verificado de manera concluyente; no redistribuir el protocolo hasta aclararlo.
Nota curatorial de derechos	No existe descarga publica para proveedores no VA.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Trauma y estrés postraumático. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	4 clústeres sintomáticos del DSM-5 más especificadores (disociación, inicio demorado).

3 Características generales

Formato	Entrevista estructurada clínica
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	30 ítems (20 evalúan los síntomas, 10 evalúan criterios de exposición, inicio, duración y afectación funcional).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Entrevista. El clínico puntúa cada síntoma en una escala de severidad general de 5 puntos (0 = Ausente, a 4 = Extremo).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	4 clústeres sintomáticos del DSM-5 más especificadores (disociación, inicio demorado).
Ítems	30 ítems (20 evalúan los síntomas, 10 evalúan criterios de exposición, inicio, duración y afectación funcional).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Entrevista. El clínico puntúa cada síntoma en una escala de severidad general de 5 puntos (0 = Ausente, a 4 = Extremo).
Relación ítem–dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Calificación por parte del evaluador. Se suman puntuaciones de severidad y se sigue algoritmo diagnóstico.

Regla de corrección	Calificación por parte del evaluador. Se suman puntuaciones de severidad y se sigue algoritmo diagnóstico.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Diagnóstico categorial (Cumple / No cumple criterios para TEPT) y medida continua de severidad global.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Es el "Gold Standard" absoluto para el diagnóstico de TEPT. Excelente fiabilidad interjueces y consistencia interna.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Es el "Gold Standard" absoluto para el diagnóstico de TEPT. Excelente fiabilidad interjueces y consistencia interna.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Validada por el Consorcio Latinoamericano y Español)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Trauma y estrés postraumático en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Weathers, F.W. et al.; 2013.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Validada por el Consorcio Latinoamericano y Español)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Estado jurídico no verificado de manera concluyente; no redistribuir el protocolo hasta aclararlo.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Trauma y estrés postraumático
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 30 ítems (20 evalúan los síntomas, 10 evalúan criterios de exposición, inicio, duración y afectación funcional).; 4 clústeres sintomáticos del DSM-5 más especificadores (disociación, inicio demorado).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Calificación por parte del evaluador. Se suman puntuaciones de severidad y se sigue algoritmo diagnóstico.
Interpretación	Diagnóstico categorial (Cumple / No cumple criterios para TEPT) y medida continua de severidad global.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Estado jurídico no verificado de manera concluyente; no redistribuir el protocolo hasta aclararlo.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Weathers, F.W. et al. (2013). Escala Administrada por Clínico para el TEPT.

Fuente de referencia del catálogo: [National Center for PTSD](https://www.ptsd.va.gov/)

<https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-int/caps.asp>

<https://doi.org/10.1037/pas0000486>

<https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/ncptsd-instrument-request-form.asp>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	CAPS-5 para DSM-5, entrevista de 30 ítems (20 síntomas + criterios asociados). No hay Protocolo.pdf local; obtener exclusivamente desde National Center for PTSD.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Entrevista clínica estructurada por evaluador capacitado.
4. Tiempo de aplicación	45–60 minutos, según la página oficial del National Center for PTSD.
5. Estructura e ítems reales	30 ítems; 20 síntomas DSM-5 puntuados en severidad más ítems diagnósticos/funcionales.
6. Periodo temporal	Último mes para la forma estándar; existen formas oficiales 'past week' y 'worst month', que deben rotularse por separado.
7. Escala/formato de respuesta	Severidad global 0–4 para cada uno de los 20 síntomas, con reglas de frecuencia/intensidad del manual.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Diagnóstico categorial (Cumple / No cumple criterios para TEPT) y medida continua de severidad global. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Distribución por National Center for PTSD/VA; obtener la forma oficial y observar sus condiciones. No reconstruir desde memoria.
13. Referencias y fuentes verificadas	National Center for PTSD. CAPS-5, https://ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-int/caps.asp ; Weathers et al., desarrollo/validación, https://www.ptsd.va.gov/professional/articles/article-pdf/id48027.pdf .
14. Decisión de QA	SOLO FICHA / PENDIENTE: no hay protocolo local; no aplicar ni reconstruir ítems. Obtener forma oficial o documentar que no fue localizada.